



其他精神分裂症谱系和精神病性障碍

作者: [Matcheri S. Keshavan](#), MD, Harvard Medical School
Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry
已审核/已修订 7月 2025

不符合精神分裂症或其他相关疾病标准的严重精神病性症状发作属于其他精神分裂症谱系和精神病性障碍。

精神病是指妄想、幻觉、思维和言语紊乱等症状，以及表明与现实失去联系的异常身体活动行为（包括紧张症）。

根据标准精神病诊断手册，其他精神障碍可分为“特定”和“未指定”两类。“特定”是指它们属于某种特定的模式，而“未指定”则是指它们不属于任何已知的类别。

这些类别指的是精神分裂症谱系或其他精神病性障碍的典型症状（如妄想、幻觉、思维和言语混乱、紧张性行为），这些症状会造成严重的社会和职业困扰和损害。然而，这些症状并不完全符合任何特定疾病的标准。这些分类有时会在精神分裂症谱系障碍尚未完全发展的早期应用。

如果医生选择说明症状特征如何不符合特定障碍的标准，则该障碍会被归类为**其他特定障碍**。例如，某人可能会出现持续的幻听，但没有其他症状，因此不符合**精神分裂症**的标准。其他特定障碍包括：

- 持续性幻听（“听到声音”）
- 妄想症与抑郁或躁狂症发作重叠
- 轻度（减轻）精神病症状
- [共同的妄想](#)

当做出诊断所需的信息不足时（例如在急诊科），就会使用**未指定**类别。

必要时，可使用[抗精神病药物](#)和精神科转诊。

共有型妄想

当人们从与他们有密切关系的人那里获得妄想时，就会发生共有型精神病。

精神病是指妄想、幻觉、思维和言语紊乱等症状，以及表明与现实失去联系的异常身体活动行为（包括紧张症）。(另请参见[精神分裂症和相关障碍简介](#)。)

共有型精神病（以前称作“双疯”）以前被认为是[妄想障碍](#)的一个子集，但现在被归类为[其他精神分裂症谱系和精神病性障碍](#)。这种疾病较为罕见，通常发生在一个人或一群人中（通常是家庭），这些人与一名患有明显妄想障碍的患者有所关联。关系中的社会主导成员患有原发性疾病，将其幻想强加于关系中主导地位弱的一个或多个成员，或说服其相信不寻常的信念。

医生试图确定关系中谁患有原发性精神病，因为继发性疾病患者与原发性疾病患者分开后通常不会维持妄想信念。咨询和治疗通常可帮助共有型精神病患者。视需要使用[抗精神病药物](#)治疗精神病症状。